INISIATIF KESIHATAN PARU-PARU KEBANGSAAN (LHI)

Rujukan Pantas · Respiratori

Kriteria rujukan, sasaran masa, MDT dan NaLuRy

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH

KRITERIA RUJUKAN DARI KK (Lampiran E)

Kanser	Lesi / nodul / massa mencurigakan pada CXR (dengan / tanpa AI) · LDCT Lung-RADS 4A, 4B, 4X atau S · atelektasis segmental / lobar · efusi pleura berulang · risiko tinggi dengan perubahan radiologi baharu
Asma	Diagnosis sukar disahkan · teruk / tidak terkawal · serangan teruk / mengancam nyawa · hamil · OCS kerap · komorbiditi (OSA, ACO) · anafilaksis · occupational asthma
COPD	Acute exacerbation · frequent exacerbator (≥2 kali setahun) walaupun rawatan optimum · respons tidak memuaskan · diagnosis tidak jelas · penilaian LTOT · disyaki ACO
Tibi	Smear-negative · extrapulmonary teruk / disseminated · kes kompleks · ADR teruk · DR-TB (disyaki / disahkan) · treatment failure · PLHIV · pediatrik · isu sosial / logistik · tidak stabil

SASARAN

80% kes disyaki kanser didiagnos secara konfirmatori dalam **≤4 minggu** dari tarikh rujukan

Rujukan bertanda **LHI** (cop borang / e-HIS / CCMS) = keutamaan

KEMAS KINI NaLuRy (HOSPITAL)

- Laporan biopsi
- Diagnosis akhir
- Pelan rawatan

MDT KANSER PARU-PARU

Perubatan Respiratori (**primary team**) · Onkologi · Pembedahan Torasik · Radiologi · Patologi · Perubatan Nuklear

PENGAMBILAN TISU

Bronkoskopi asas & EBUS, pleuroscopy: Respiratori
Image-guided biopsy: Radiologi
Surgical biopsy / resection: Bedah Kardiotorasik

HOSPITAL RESPIRATORI & PATOLOGI ANATOMIK

H. Sultanah Bahiyah · H. Sultan Abdul Halim · H. Kulim
Rujukan LDCT dari 6 hospital CT: HSB, HSAH, H. Kulim, H. Pendang, H. Baling, H. Sultanah Maliha

HUBUNGI

Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah · 04-7741156 · ncdjkn.kdh@moh.gov.my

Rujukan: Garis Panduan Pelaksanaan LHI JKN Kedah 2026 (Indikasi Rujukan ke Hospital, Lampiran E) · GP LHI KKM 2026